Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 27ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810240

Processo nº **0061750-63.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): M. C. D. C. S.

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

De pronto, tenho por bem adotar o relatório da decisão concessiva do pleito antecipatório de id. 134791249, pois, além de refletir a narrativa fática, garante celeridade ao trâmite processual (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal):

*Trata-se de ação sob o procedimento comum, em que a parte autora **MATHEUS CUNHA DA COSTA SOUZA**, menor impúbere, representado por seu genitor, EDUARDO CUNHA DA COSTA BEZERRA**,** ambos qualificados na inicial**,** por meio de advogado legalmente habilitado, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a operadora de plano de saúde **UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED RECIFE),** igualmente qualificada, forneça a medicação Omnitrope 10mg/1,5ml, Solução Injetável (1un de 1,5ml) – Sandoz, Somatropina 10mg/1,5ml, aplicar 0,6 mg, subcutâneo, à noite ao deitar. CID: P05.1, uso contínuo 02 refis por mês, até o final do crescimento que seria com dezesseis anos de idade óssea, como também possíveis aumentos de dosagens no futuro ou a substituição por outro medicamento seguindo sempre as orientações do profissional médico assistente, bem como, a cobertura de todos os materiais indispensáveis ao referido tratamento, devidamente prescritos na solicitação médica de id. 134732863 e Laudo de id. 134732862.*

Alega o representante legal da parte autora que o infante apresenta baixa estatura secundária - CID: P05.1, causado por ter nascido pequeno para a idade gestacional (PIG), não apresentando recuperação pós-natal, pelo que foi-lhe indicado, com urgência, tratamento hormonal de crescimento, visando aumentar a velocidade de crescimento e normalizar a altura durante a infância, a adolescência e a vida adulta.

Aponta ainda que o aludido medicamento tem previsão de cobertura no rol de procedimentos da ANS (Resolução 465/2021, id. 134732874) e com custo elevado (id. 134732868, 134732869 e 134732870), porém, a parte demandada recusou o custeamento, sob a alegação de que o contrato e a legislação vigente não prevê tal cobertura (id.134732865).

Assim, pugna por provimento de urgência no sentido de que a parte ré seja compelida a fornecer-lhe a medicação objeto da demanda, na forma prescrita, sob pena de multa. ***No mérito, requereu a confirmação da liminar e condenação da demandada por danos morais (R$ 10.000,00) e demais verbas sucumbenciais.***

Junta ainda a carteira do plano de saúde da menor, id. 134732859; comprovantes de pagamento dos prêmios mensais id. 134732860; as condições gerais do contrato, id. 134732861.

Petição de id. 135830626, em que a parte demandada anuncia o cumprimento da medida liminar.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou defesa em forma de contestação, id. 137349998. Alega, em suma, preliminar de chamamento ao processo do Estado de Pernambuco, sob argumento que tal ente tem responsabilidade por ser o gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) e é o fornecedor do medicamento de administração domiciliar a cidadão carente, conforme orientação da Súmula 18 do TJPE.

No mérito, reconhece a recusa do fornecimento do referido medicamento por ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme estabelece o art. 17, parágrafo único, inc. VI, da Resolução Normativa ANS – RN 465/2021, assim como as previsões contidas nos arts. 10, inc. VI, e 12, inc. I, "c", e, inc. II, "g", da Lei 9.656/1998. Defende a negativa com base no artigo 30, "f", do contrato, que prevê a inexistência de obrigatoriedade de cobertura de medicamentos fora do regime de internação hospitalar, sendo que a cobertura em regime domiciliar abrange apenas medicação de natureza antineoplásicas, que não é o caso destes autos. Em linhas gerais, argui que o fornecimento do medicamento viola o equilíbrio da relação contratual e que está amparada pelo exercício regular de um direito, ao passo que o autor deveria arcar com os custos de forma particular ou por meio do Sistema Único de Saúde -SUS; que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto agiu em atenção às previsões contratuais e jurisprudenciais, inexistindo, portanto, dano moral indenizável. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e requereu a condenação da parte autora no ônus sucumbencial.

Junta documentação, especialmente o contrato encetado pelas partes, id. 137350002; parecer, id. 137350007; jurisprudência, id. 137350008 e seguintes.

Réplica de id. 141921850.

Intimadas as partes para produção de novas provas, ambas pediram o julgamento antecipado da causa, id. 147026462 e 147897977.

Parecer do R. MP, opinando pela procedência da ação

Vieram-se os autos conclusos.

É o relatório. **Decido.**

Impende destacar que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no art. 355, inc. I, do Código Processo Civil em vigor, porquanto a matéria controvertida é essencialmente de direito, de modo que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

Da preliminar de chamamento ao processo do Estado de Pernambuco.

Não prospera a preliminar invocada. O art. 130 do CPC em vigor dispõe sobre aludido instituto jurídico que consiste na possibilidade de inclusão de devedor principal ou coobrigados por dívida para integrar o polo passivo de relação jurídica já existente, em que o juízo irá declarar na sentença a responsabilidade de cada um.

No entanto, a situação narrada nestes autos não se enquadra em qualquer das hipóteses de chamamento ao processo previstas na legislação ora vigente. Relevo, por oportuno, que a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

É cediço que o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental do cidadão, o qual pode ser pleiteado de qualquer ente federativo da República (solidariedade), desde que demonstrada a necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

O art. 196 da CF/88, no qual se lastreou a parte demandada, é a resposta ao direito fundamental à saúde previsto no art. 6° da CF/88. Desta norma social se extrai o conceito de mínimo existencial, compreendido como o plexo de bens mínimos exigíveis a fim de materializar a dignidade da pessoa humana. Vale dizer que vivemos num Estado de constante crise social, com um grande contingente de cidadãos socialmente excluídos e as normas constitucionais referenciadas a eles objetivam, o que não é o caso da parte autora.

Nessa ordem de ideais, o autor não pode ser considerado pessoa carente, de baixa renda, a fim de receber a proteção do Estado quanto ao tratamento da moléstia que o aflige. Em verdade, o autor é beneficiário de plano de saúde, ao qual paga prêmio mensal há 4 (quatro) anos, justamente para ter garantida a prestação de serviços e tratamentos médicos quando necessitar, pois é o fim precípuo do contrato privado ora encetado pelas partes.

Além de inexistir base legal para tanto, a ré não demonstrou a existência de que sua obrigação é solidariamente repartida junto à entidade federativa pelo fornecimento do medicamento objeto do feito. **Indefiro, portanto, a preliminar suscitada.**

Do Mérito

De saída, repiso e mantenho as razões contidas na decisão de id. 134791249, atinente à aplicação da legislação consumerista (STJ, Súmula 608), assim como à vedação às condutas abusivas contra o consumidor que violam a boa-fé e o equilíbrio contratual e promovem desvantagem contratual (art. 51, inc. IV, do CDC), o que já é suficiente para as razões autorais prosperarem.

É cediço ainda que o negócio jurídico se submete às demais normas do nosso ordenamento jurídico, a saber, a Constituição Federal, o Código Civil e a Lei 9656/98.

Como se sabe, a saúde é direito fundamental de todo cidadão, sendo a assistência à saúde de livre iniciativa de pessoas jurídicas de direito privado que integram o sistema de saúde complementar, sob a fiscalização da Agência Nacional de Saúde.

Nessa condição de operadora de plano de saúde, a demandada está subordinada também às normas e princípios que regulam o direito privado, devendo sempre preponderar a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Sob essa ótica, sabe-se que os contratos firmados entre as operadoras de planos de saúde e os seus usuários tem por finalidade precípua a prestação de serviços médicos e hospitalares, visando à saúde e ao bem-estar do beneficiário; de outro lado, deve-se ressaltar que as empresas operadoras de planos de saúde não podem impor aos usuários cláusulas, cujo conteúdo afronte a relevante função social de tais contratos.

Dessa forma, entendo que, em se tratando de contratos de adesão, as cláusulas contratuais que limitem ou impliquem em renúncia a direito inerente à natureza do contrato não podem prevalecer, sob pena de afronta aos Princípios do Equilíbrio Contratual, Probidade, da Boa-fé Objetiva e da Função Social do Contrato.

Com tais considerações passo a análise da questão de fundo.

A demanda ocorre em função da obrigatoriedade, ou não, do custeio das despesas referentes à realização de tratamentos medicamentosos, conforme laudo médico anexo no id. 134732862, que, pela recusa da cobertura pela ré (id. 134732865), levou a parte autora a ingressar em Juízo para obter o bem da vida pretendido e a preservação da sua saúde.

Salvo melhor juízo, é induvidoso a imprescindibilidade do menor autor se submeter ao tratamento medicamentoso indicado pela especialista que o acompanha, a fim de se ter um desenvolvimento regular e saudável, *devido baixa estatura secundária à PIG* (Pequeno para Idade Gestacional - CID: P05.1), podendo chegar na vida adulta com a altura abaixo de 1.60 cm. Aponta ainda que tratamento visa *aumentar a velocidade*

de crescimento e normalizar a altura durante a infância, a adolescência e a vida adulta, sendo promissor *na recuperação do crescimento e da altura adulta dentro do esperado para a população,* e que a eficácia é maior *quanto mais precoce for iniciado e quanto melhor for a altura no início da puberdade.*

Depreendo ser oportunidade única de tratamento hormonal de crescimento, a qual não deveria ser perdida, por estar em fase de puberdade. Mesmo assim, tal quadro não foi suficiente para a empresa ré considerar o direito à saúde da demandante, porquanto não autorizou o custeio do aludido medicamento, conforme orientação médica, sob argumento de que a demandada é regida por cláusulas que limitam e especificam os riscos cobertos, notadamente por não ser de uso ambulatorial ou hospitalar.

A tese defendida pela empresa ré não é nova, ao contrário, é sempre e reiteradamente apresentada e afastada pelos Tribunais. Em verdade, quando o plano de saúde não autoriza imprescindível tratamento medicamentoso, restringe o direito fundamental à saúde, porque o tratamento indicado é inerente à natureza do contrato.

É evidente que, quando o consumidor procede com a contratação de plano de saúde, o mesmo não busca apenas a cobertura parcial de determinado tratamento incluído no contrato, isso porque é óbvio que toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar determinada doença deve ser coberta, sob pena de inviabilizar a própria fruição do plano contratado.

O contrato de saúde tem como finalidade social a preservação da saúde. Não pode a prestadora de saúde, por isto, negar assistência integral, incluindo o fornecimento de medicamento indicado por médico para o controle de patologia. Tal prática contraria a função social do contrato, em ofensa ao artigo 421 do Código Civil.

Convém dizer que a assistência à saúde é permitida à iniciativa privada, que pode explorá-la com objetivo de lucro, porém, oferecendo-se, em contrapartida, serviço adequado, de qualidade, que assegure a saúde daquele que contrata o serviço, mantendo-se o respeito às normas constitucionais. Neste sentido, tenho que a recusa por parte da seguradora destoa da finalidade do próprio contrato de seguro saúde, que é assegurar a preservação da saúde, bem intrinsecamente relevante à vida, sendo direito absoluto.

Cumpre mencionar que a medicina está sempre em evolução e é certo que tratamentos antes feitos apenas em ambiente ambulatorial-hospitalar, podem ser substituídos pelo ambiente domiciliar, fato que não alteraria a natreza do contratual do plano de saúde, cuja função social, repiso, é o de permitir que o usuário tenha efetiva e completa assistência, nos limites do contrato (art. 421 do CC).

A questão não é sobre cláusula exclusória, mas, sim, de adaptação e de se interpretar um conceito moderno de tratamento, não sendo relevante o local onde ele será realizado. Por demais, nesse caminho de ingestão em ambiente domiciliar, além de ficar menos oneroso à fornecedora do serviço, impõe-se um tratamento mais humanizado ao paciente, bem assim, deixa-o imune a infecções hospitalares ou outros riscos constantes em nosocômios.

Não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico a negativa de fornecimento do referido remédio, estando a vida e a dignidade da pessoa humana como valores situados em patamar superior em relação às decisões econômicas de operadoras de saúde.

Nessa trilha, não deve prevalecer a negativa da parte ré em custear o medicamento recomendado por especialista, ainda que este seja de uso domiciliar. Aliás, ressalte-se, somente podem ser excluídos da cobertura do plano de saúde os medicamentos simples, anti-inflamatórios, analgésicos, isto é, os de uso comum e não aqueles essenciais a um tratamento clínico específico e mais complexo.

Nesse contexto, é de competência do médico que acompanha o paciente, e não da seguradora, a escolha da terapia atinente à sua patologia, esta que é assegurada pelo plano, não sendo relevante se tratar de medicamento de uso domiciliar. Em verdade, desnecessário que o contrato de prestação de serviço à saúde

expresse relação de cada um dos procedimentos a que os beneficiários têm direito, nem quais são adequados ao tratamento de cada moléstia. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças são cobertas, contudo, não o tipo de tratamento que está ao alcance da respectiva cura.

Infere-se, então, que a recusa perpetrada pela demandada resta eivada de ilegalidade, pois não poderia negar o tratamento com hormônio de reposição, no momento em que a parte demandante mais precisa, mormente quando acometida, como visto, por PIG (CID P05.1), patologia singular que pode afetar não somente o aspecto físico, mas também o psicológico, caso a parte tenha, já na adolescência, uma estatura inferior a 1.60 cm.

Vide decisões sobre a espécie:

*Apelação Cível n. * Apelante: Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico Apelada: V. C. G. Relator: Des. Eduardo Sertório Canto* ***EMENTA****: Apelação cível. Plano de saúde.* ***Segurado diagnosticado com déficit de crescimento. Fornecimento de medicamento. Hormonioterapia. Dever de cobertura. Previsão legal. Danos Morais. Configurados.*** *Recurso não provido por unanimidade. 1) Cabe aos profissionais de saúde avaliar a situação de saúde de seus pacientes e, com base nisso, indicar-lhes o melhor tratamento. 2) Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para a cura de cada uma delas; 3) O fornecimento do hormônio do crescimento consta do rol da ANS. Dessa forma, a seguradora está obrigada ao fornecimento do hormônio do crescimento, já que o tratamento é de cobertura obrigatória e deve constar no contrato. 4) Estando prevista contratualmente a cobertura de tratamento endocrinológico, não há como a seguradora excluir o tratamento indicado pela equipe médica do segurado, haja vista ser essencial à possibilidade de cura da patologia por ele apresentada. 5) A negativa de cobertura já é suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral, não havendo necessidade de comprovação do dano suportado pelo segurado. 6) Devida a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no o art. 85, § 11, do CPC. 7) Recurso não provido por unanimidade. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da apelação cível n. 0027701-64.2021.8.17.2001, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório, do voto e da ementa que integram o julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator @* ***(TJ-PE - AC: 00277016420218172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)***

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MENOR DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DE BAIXA ESTATURA. DÉFICIT NA PRODUÇÃO DE HORMÔNIO. GRANDE ATRASO NA IDADE ÓSSEA. NECESSIDADE DE SUPRIR DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH) NO ORGANISMO. ***MEDICAMENTO CONTENDO PRINCÍPIO ATIVO SOMATROPINA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NA ANVISA****. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. RECUSA EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. ROL EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DA LEI 144/54/22.*

Aos contratos de seguro aplica-se o CDC, por encerrarem relação de consumo, e desse modo, devem ser interpretados segundo as regras de tal lei, ainda que regulamentados em outros textos legais. Por conseguinte, nos contratos de adesão, como ocorre no caso em exame, deve se sobrepor à letra da lei a boa-fé dos contratantes, que visam nos planos de saúde contratados, a assistência médica devida para plena manutenção de sua saúde, bem como o equilíbrio contratual. Nesse sentido, dispõe o CDC em seu art. 51, V. Depreende-se dos autos que o agravado é menor segurado da operadora de saúde agravante, estando adimplente com suas obrigações. O paciente segurado foi diagnosticado, segundo laudo médico (ID 102726369 – autos de origem) como portador de baixa estatura, secundária a um déficit parcial na produção do hormônio de crescimento (GH) (CID: E 23.0), evidenciado nos dois testes de estímulo realizados por ele (Clonidina e ITT), assim como pelo grande atraso na sua idade óssea, sendo-lhe prescrito iniciar tratamento com hormônio de crescimento (Somatropina na dose de 0,045 mg/kg por dia, por um período aproximado de 06 anos), ressaltando o laudo que caso a reposição não seja realizada urgentemente o paciente ficará com altura final muito abaixo do padrão populacional e genético, já que o mesmo não produz hormônio de crescimento, sendo esse o único tratamento disponível para a recuperação de seu quadro clínico.

Quanto à obrigação das operadoras de saúde fornecerem/custearem medicação de uso domiciliar não há discussão, quando se trata de antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (home care) e os medicamentos incluídos no Rol da ANS para esse fim. No entanto, afora tais casos excepcionais,

outras hipóteses também justificam tal obrigação, como a presente. O medicamento almejado possui custo elevado e é imprescindível para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente menor, a qual é coberta pelo contrato celebrado entre as partes. Havendo previsão contratual de cobertura da enfermidade, não pode a seguradora negar o tratamento sob pena da recusa ser considerada abusiva consoante a legislação retrocitada. Destaque-se, ademais, que cabe somente ao profissional médico que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua cura ou melhora.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo. Revela-se inidônea a recusa em custear a realização do tratamento/medicação expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, sob o argumento de não estar previsto no rol ou não contratado junto à operadora de saúde. OUTROSSIM, RECENTEMENTE FOI PUBLICADA A LEI 14454/22, JÁ EM VIGOR, a qual "Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar." Dispõe o §13 do art. 2° da referida Lei que: "§ 13.Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I- exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou Ver tópico II- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Justamente nesse contexto, se enquadra a hipótese vertida nos autos, vez que existe comprovação científica da eficácia do tratamento com a medicação contendo o princípio ativo SOMATROPINA, que se encontra atualmente registrado na ANVISA. Agravo ao qual se nega provimento. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0010956-27.2022.8.17.9000, Rel. ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins, julgado em 24/10/2022, DJe)

Por todo o exposto, revela-se injusta a negativa de cobertura perpetrada pelo plano de saúde e se faz necessário confirmar a decisão liminar ora exarada, em todos os seus termos, prosperando o pleito alusivo à obrigação de fazer da demandada de custear o tratamento medicamentoso indicado pela médica assistente da parte autora.

Nesse caminho, está configurada a conduta abusiva da parte ré, devendo-se, logo, analisar os danos materiais e morais.

Os danos morais devem ser apreciados pelo aspecto pedagógico para que o ofensor não volte a repetir a mesma conduta indevida/injustificada que não autorizou a cobertura financeira do medicamento, no momento em que a parte autora mais precisa, impondo-a a conviver com a incerteza de ver seu tratamento trazer-lhe os benefícios pretendidos. É fato que extrapola o simples desconforto ou contrariedade, tendo dimensão e intensidade suficientes para caracterizar o dano moral.

Insta frisar que o TJPE editou a Súmula 35 que faculta ao magistrado impor indenização por danos morais quando a negativa de cobertura for fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde: *a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.*

No arbitramento do valor da reparação, considera-se as circunstâncias do caso concreto, da urgência e gravidade da situação, as condições econômicas das partes, o grau de culpabilidade da ré e a vertente pedagógica da indenização. Diante dessas premissas, fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, decreta-se a procedência desta ação, incidindo-se na espécie a previsão dos arts. 421, 422 e 423 do CC, da legislação consumerista e das normas principiológicas de matriz constitucional.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido de condenação da ré na obrigação de fazer correspondente à cobertura e custeio do tratamento medicamentoso, na forma indicada pela médica assistente no laudo anexado aos autos, **confirmando os termos da decisão antecipatória de id. 79185983.**

Condeno a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (Súmulas 156 do TJPE) e correção monetária pela Tabela do ENCOGE a partir desta decisão (Súmulas 362 do STJ e 160 do TJPE), tudo até o efetivo pagamento.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação indenizatória, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, acrescido de R$ 500,00 (quinhentos reais) no tocante à condenação na obrigação de fazer, por ter valor inestimável (art. 85, § 8º, CPC).

Em consequência, ponho termo ao processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Verificada a inércia da parte interessada, e ausente qualquer pendência alusiva às custas processuais, arquive-se, independentemente de nova conclusão.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, pois, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo 2º Grau, na forma do artigo 1.010, § 3º, CPC.

Por haver interesse de menor ou incapaz, ciência ao MP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife (PE), 18 de janeiro de 2024.

José Arnaldo Vasconcelos da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JOSE ARNALDO VASCONCELOS DA SILVA
18/01/2024 12:21:20
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 158301686

24011812212087200000154626502

IMPRIMIR GERAR PDF